CO-INFECTION PALUDISME GRAVE ET DENGUE CHEZ LES ENFANTS AU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE TENGANDOGO

Nom du présentateur : DAO Lassina

Auteurs et coauteurs :DAO L, TRAORE O. L;DJIGEMDE A. A .K, COULIBALY Y S, BOUGOUMA R, DEMBELE E.

Plan

- Introduction
- Objectif
- Matériel et méthode(s)
- Résultats
- Conclusion

Introduction

- **Infections concomitantes**

  Pourraient être encore plus mortelles

- **Prévalence combinée co-infection paludisme et dengue**

  4,2 % dans 8 pays africains ; enfants +++

  Yugbaré et al 2019 : **16,2 %** en 2019

  CHU P : **55,24% avec moins de 5 ans +++** en 2019

  CHU YO : **12,90% chez enfants de 0 à 5 ans** en 2023

Objectif

OBJECTIF GENERAL

Étudier la co-infection paludisme grave et dengue chez les enfants

OBJECTIFS SPECIFIQUES

- ✓ Déterminer la fréquence de la co-infection paludisme et dengue
- ✓ Décrire les aspects cliniques et biologiques de la co-infection
- ✓ Décrire la prise en charge thérapeutique de la co-infection
- ✓ Déterminer les modalités évolutives de la co-infection
- ✓ Identifier les facteurs associés au décès

Matériel et méthode(s)

- Cadre de l'étude

  Service pédiatrique CHU T

- Type et période de l'étude

  Transversale, visé descriptive et analytique collecte rétrospective du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2024

- Population d'étude

  Tous enfants admis pour paludisme associé à dengue confirmée ou probable au sein du CHU T

Matériel et méthode(s)

- Critères d'inclusion :Tous les enfants âge entre 0 à 15 ans en consultation et admis aux urgences pédiatriques chez qui le diagnostic positif de paludisme et de dengue a été confirmé par des examens biologiques durant leur séjour au CHUT

- Critères de non inclusion

  Patients atteints de paludisme sans dengue ; sortis contre avis médical ; Sérologie dengue non réalisés.

Matériel et méthode(s)

- Collecte et analyse des données

  Collecte : dossiers médicaux ; registres de comptes rendus des résultats d'examens de biologie

  Analyse et saisie : Epi info ; Word et Excel version 2016

- Aspects éthiques et déontologiques

  approbation de la Directrice Générale du CHU-T

  respect d'anonymat et confidentialité

Résultats

Fréquence hospitalière : **2,04%**

Mois d'octobre : **31,43%**

- Âge moyen : **5,47 ± 3,66 ans ; [1 et 15] ans**
- Tranche âge : **[2-11] ans 87,86 %**

➢ Sexe

- Masculin : **60,71%**
- Sexe ratio : **1,54**

Résultats

- Motifs d'admission
  - Fièvre : **80,71%**
  - Vomissements : **37,86%**
  - Douleur abdominale : **29,29%**
- Etat général
  - Hyperthermie : **98,57%**
  - Etat nutritionnel bon : **85,71%**

Résultats

- Signes généraux de danger
  - Vomissements : **49,29%**
  - Léthargie : **23,57%**
- Signes de gravités
  - Hémorragie diffuse : **38,35%**
  - Coma : **25,56%**
  - Détresse respiratoire : **17,29%**

Résultats

- Densité parasitaire
  - Moyenne : **10575,84 ± 3362,02 Trp/ µl** ; **[50 et 327600]**
- Sérologie dengue
  - IgM positif : **36,43%**
- Biologie
  - Anémiés : **97,14%**
  - Thrombopénie **91,43%**

Résultats

❑Prise en charge

- ➢ Correction des troubles métabolique
  - ▪ Hyponatrémie corrigé : **45,45%**
  - ▪ Hypoglycémie corrigée : **40,91%**
- ➢ Transfusion sanguine **:** **94,28%**
- ➢**Oxygène :** **30 %**

Résultats

❑Evolutions-pronostics

- Mode de sortie
  - Guéris : **70,71%**
  - Mortalité : **25,71%**
  - Soties contre avis médical : **3,57%**
- Durée d'hospitalisation
  - Moyenne : **6,371 ± 3,66 jours** ; **[1 jour et 23 jours]**
  - Durée 1 à 7 jours : **77,86%**

Résultats

❑ Analyse multivariée

➢ Facteurs associés à survenue de décès

- Niveau scolaire du père non scolarisé, primaire
- Enfant qui vomit tout ce qu'il consomme
- Incapable de boire ou de téter
- Coma ; Convulsions répétées
- Anémie normocytaire normochrome
- Thrombopénie et leucopénie

Conclusion

- Co-infection paludisme-dengue
- Morbidité et mortalité élevée, formes sévères marquées par complications hémorragiques, neurologiques et respiratoires
- Principaux facteurs associés au décès : vomissements incoercibles, coma, thrombopénie, leucopénie et faible niveau d'instruction du père
- Nécessité : Prise en charge rapide et adaptée ; Mise en place d'actions de prévention renforcées

Merci pour votre attention